

# 미주신경성 실신, 알면 예방하고 대처할 수 있습니다

자율신경이 과반응해 일시적으로 뇌혈류가 줄어드는 양성 실신 — 생명에 지장은 없습니다

## 실신 (Syncope) 이란

전반적 뇌혈류 감소로 인해 발생하는 일시적 의식 소실 — 평균 6~8초 내 회복

**6 – 8초**

뇌로 가는 혈류가 6~8초간 중단되면 누구든 의식을 잃을 수 있습니다 — 이후 자세를 낮히면 곧 회복됩니다.



### 왜 중요한가요

미주신경성 실신은 흔한 원인이지만, 위험한 심장성 실신과 구별해야 합니다. 유발 상황과 전조 증상을 살피면 어떤 검사가 필요한지 판단하는 데 도움이 됩니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope Guideline · ACC/AHA/HRS 2017

# 미주신경성 실신 (Vasovagal Syncope) 이란

자율신경 과반응으로 일시적 뇌혈류 부족이 일어나는 양성 실신

## 핵심 설명

자율신경이 갑작스러운 자극에 과민하게 반응해 혈관이 확장되고 심장 박동이 느려지면서 일시적으로 뇌혈류가 줄어드는 상태입니다.

## 자세히

자율신경 반응으로 뇌혈류가 일시적으로 줄어드는 상태입니다. 넘어져 다치지 않도록 하고, 위험한 심장성 실신과 구별해야 합니다.

## 보통 회복 시간

수 초 ~ 수 분 · 눕히면 빠르게 회복되며, 의식이 또렷해지는 시간도 짧습니다.

## 평생 경험 비율

3명 중 1명 · 평생 한 번은 경험할 수 있을 만큼 매우 흔한 양성 질환입니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope Guideline · 평생 경험 비율 자료

## 왜 생기나요? — 자율신경의 과민 반응

두 기전이 단독 또는 함께 작동해 뇌혈류 부족을 일으킵니다

### 혈관 억제 (Vasodepression)

교감신경 활동이 떨어지고 혈관이 갑자기 늘어지면서 혈압이 급격히 떨어집니다. 전신을 도는 압력이 약해져 뇌로 가는 혈류가 6~8초 이상 부족해지면 일시적 의식 소실이 발생합니다.

### 심장 억제 (Cardioinhibition)

미주신경이 우세해지면서 심장 박동이 갑작스럽게 느려지거나(서맥), 짧게 멈출 수도 있습니다(심장 일시정지). 심박출량이 떨어져 뇌로 보내는 혈류가 줄어들면서 의식이 흐려집니다.

### 두 기전의 혼합형

실제 임상에서는 혈관 억제와 심장 억제가 함께 일어나는 혼합형이 가장 흔합니다. 어느 쪽이 우세한지에 따라 환자가 느끼는 전조 증상과 회복 양상이 달라집니다.

### 결과 — 일시적 의식 소실

뇌혈류가 6~8초간 중단되면 누구든 의식을 잃습니다. 자세를 눕히면 중력 영향으로 혈류가 회복되어 곧 의식이 돌아옵니다 — 이것이 "쓰러짐"이 신체의 자기 보호 반응인 이유입니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope Guideline · Reflex syncope mechanism

## 이런 상황에서 잘 생깁니다

유발 상황을 알아두면 미리 알아 실신을 예방할 수 있습니다

### 오래 서 있기

조회 시간, 만원 지하철, 식전 사진 촬영, 야외 행사로 오래 서 있을 때 피가 다리로 몰리면서 뇌혈류가 부족해 발생하기 쉽습니다.

### 감정 스트레스 · 통증

극도의 공포·놀람·당황, 채혈 장면 목격, 또는 극심한 통증·자극이 자율신경 균형을 깨뜨려 미주신경 반사를 과흥분시킵니다.

### 의료 행위 (보기)

주사를 맞거나 채혈할 때, 치과 진료, 응급실에서 피를 보는 상황에서 반사적으로 매우 흔하게 유발됩니다.

### 더운 환경

사우나, 한증탕, 무더운 여름날, 무리한 야외 활동 등에서 혈관이 확장되어 피가 다리에 더 몰리게 됩니다.

### 탈수 · 공복

수분 섭취가 부족하거나 장시간 굶은 뒤, 격한 운동 후 수분 부족으로 혈장이 줄면 혈관 내 압력이 잘 유지되지 않습니다.

### 상황 실신 (배변 · 배뇨)

야간에 화장실에서 배뇨·배변을 보거나, 또는 심한 기침을 거둬할 때 미주신경이 자극되어 발생하기도 합니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Reflex Syncope · Trigger Classification

## 미주신경성 실신 vs 심장성 실신 구별 포인트

전조 증상·유발 상황·자세 등으로 위험도를 가늠할 수 있습니다

### + 미주신경성 실신 (양성)

- 전조 증상 있음 — 어지러움·식은땀·시야 흐림
- 오래 서 있기·통증·감정·더위 등 명확한 유발 요인
- 서 있거나 앉은 자세에서 발생
- 의식 소실 시간 짧음 (수 초~수 분)
- 눕히면 빠르게 회복, 후유증 없음
- 젊은 성인·여성에서 흔함

VS

### ! 심장성 실신 (위험)

- 전조 증상 없이 갑작스러운 의식 소실
- 운동 중·운동 직후 발생
- 누운 자세에서도 발생
- 흉통·두근거림·호흡곤란 동반 가능
- 심장 질환이나 돌연사 가족력
- 회복 후에도 무력감·혼동 지속 가능

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope Guideline · Cardiac vs Reflex Differential

## 전조 증상이 오면 즉시 이렇게! (PCM)

근육 반동 수기 (Physical Counter-Pressure Maneuver) — 들어두면 실신을 예방할 수 있습니다

### 다리 교차 후 근육 조이기

선 자세로 양 다리를 X자로 꼬고 배·엉덩이·허벅지 근육에 30초 이상 강하게 힘을 줘 혈류를 심장으로 보냅니다.

### 양손 깍지 끼고 세게 당기기

양손을 가슴 앞에서 깍지 끼고 서로 반대 방향으로 있는 힘껏 당깁니다. 고무공이나 수건을 쥐는 것도 좋습니다.

### 즉시 그 자리에 앉거나 눕기

가장 안전하게 머리를 보호하는 동작입니다. 혹시 의식을 잃더라도 부딪혀서 머리를 다치는 상황을 막아 줍니다.

### 앉거나 누워 쉬면서 회복

어지러우면 즉시 주변을 살펴 안전한 곳에 앉거나 눕습니다. 뇌혈류가 회복되어 곧 또렷해집니다.



PC-Trial RCT(2006) — 근육 반동 수기(PCM)는 단독 표준 치료만 받은 자에 비해 실신 재발을 39% 유의하게 감소시켰으며, 가장 안전한 1차 대처법으로 권장됩니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · PC-Trial RCT 2006 · ESC 2018 Class I Recommendation

## 매일 실천해 보세요 — 5가지 일상 습관

예방의 핵심은 충분한 수분과 적절한 염분, 그리고 자세 습관

### 물 1.5 ~ 2 L 충분히

기상 직후, 식전, 운동 전후로 의식적으로 수분을 마시기. 한 번에 많이가 아니라 자주 나누어 섭취하는 것이 효과적입니다.

### 적절한 염분 섭취

과도한 제한은 피하고 하루 소금 6~10g 권장 (ESC 2018 가이드라인 기준). 단, 고혈압·신질환이 있으면 의사 상담 후.

### 유발 상황 피하기

더운 환경(사우나 등) 회피, 공복 상태로 장시간 서 있지 않기. 만원 지하철 등 밀폐·고온 환경을 짧게 유지.

### 단계적 기립 주의

눕거나 앉은 자세에서 일어날 때는 30초 정도 천천히. 서기(중간), 짧은 정지(잠깐), 완전 기립 순으로 시야 안정 후 이동.

### 압박 스타킹 / 복대 활용

정맥 환류 개선으로 피가 다리에 물리는 부분을 막아 줍니다. 실신이 자주 재발하는 분, 수분 섭취만으로 부족한 분에게 권장.

### "약보다 더 중요"

약물 처방 전 먼저 시도해야 할 핵심 1차 치료입니다. 매일의 작은 습관이 실신 빈도와 강도를 의미 있게 줄여 줍니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Syncope · Lifestyle modification first-line

## 이런 실신은 위험합니다 (Red Flags)

미주신경성 실신과 다르게, 반드시 심장 정밀 검사가 필요한 경고 신호

### 운동 중 실신 — 휴식 시 X, 운동 중 발생

운동 직후가 아닌 운동하는 도중에 쓰러지는 경우, 심장 구조 이상이나 부정맥 등 치명적인 구조적 심장 질환을 의심해야 합니다.

### 누운 자세에서 실신

일반적인 반사성 실신은 주로 서 있을 때 발생합니다. 누워 있거나 앉아 있는 자세에서의 실신은 심장성(부정맥) 원인일 가능성이 높습니다.

### 전조 증상 없는 갑작스러운 실신

어지러움·식은땀·메스꺼움 등 어떠한 경고 신호도 없이 수 초간 쓰러지는 경우, 심한 서맥이나 완전 방실차단 등 위험한 상태일 수 있습니다.

### 가족 중 급사 병력 (55세 미만)

가족이나 친척 중 젊은 나이에 원인 모를 심장 마비로 사망한 분이 있다면, 긴 QT 증후군 등 유전성 심전도 질환의 가능성을 반드시 평가해야 합니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 High-Risk Features · Cardiology referral indications

## 어떤 검사를 받나요? — 단계적 접근

대부분 1차 검사만으로 충분히 진단 가능 — 위험 신호가 있을 때만 2차 검사

### 상세 병력 청취

유발 상황, 전조 증상, 자세, 목격자 진술을 종합 — 이것만으로 미주신경성 실신을 70% 이상 진단할 수 있습니다.

### 신체 진찰

심잡음, 누운·선 자세 혈압, 신경학적 이상 여부를 진찰합니다. 기립 후 3분간의 혈압·맥박 변화 비교가 핵심.

### 12 유도 심전도 (ECG)

부정맥, 전도 이상, 유전성 심질환 등 심장성 실신을 감별하기 위한 필수 기본 검사입니다.

### 기립 경사 검사 (HUT)

기울어지는 침대에서 혈압·맥박 변화를 관찰. 미주신경성 실신을 객관적으로 재현하기 위한 검사입니다.

### 심장 초음파 / 24시간 홀터

초음파로 구조적 심장 질환을 평가. 24~48시간 홀터 모니터링으로 일상에서의 부정맥 동반 여부를 확인합니다.

### 이식형 사건기록기 (ILR)

원인 불명 재발성 실신에서 부정맥 검출용으로 피부 아래에 작은 기기를 삽입 — 매우 드문 경우에만 적용.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · ESC 2018 Diagnostic Algorithm · Class I Tests

## 오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

미주신경성 실신은 안전하지만, 알아두면 예방하고 위험 신호를 구별할 수 있습니다

**01** 미주신경성 실신은 대개 위험하지 않지만 원인 감별이 필요한 실신입니다

**02** 유발 상황(더위·통증·오래 서기 등)을 알아 피하기가 핵심

**03** 전조 오면 즉시 그 자리에 앉거나 눕기 + 다리 꼬기

**04** 물을 충분히 마시고 일어날 때는 3단계(눕→앉→서)로

**05** 근육 반동 수기(PCM)로 재발 39% ↓ (PC-Trial)

**06** 압박 스타킹·복대로 정맥 환류 개선 가능

**07** 운동 중·누운 자세·전조 없음 → 즉시 검사 필요

**08** 젊을수록 가족 급사 병력 있으면 심장 정밀 검사로

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · Daily action plan — recognise triggers, apply PCM, identify red flags

## 다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

### **광교바른내과**

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

### **이 자료의 성격**

환자와 보호자를 위한 설명자료입니다. 진단과 처방은 담당 의료진과 상의하세요.

### **참고한 자료**

ESC 2018 실신 지침 · ACC/AHA/HRS 2017 실신 지침



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 휴대폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요